

VÍA VENOSA PERIFÉRICA

Santiago Manuel Fernandez Manovel, Jose María Fernández García.

La canalización de una vía venosa periférica es una técnica mínimamente invasiva que nos permite tener un acceso permanente al sistema vascular del paciente con fines diagnósticos y/o terapéuticos. A través de esta vía podremos administrar sueroterapia, medicación y nutrición parenteral, entre otras cosas.

INDICACIONES

- Extracción de muestras sanguíneas
- Administración de fluidos
- Administración de medicamentos

MATERIAL

- Compresor
- Gasas estériles
- Antiséptico tópico (clorhexidina o povidona iodada)
- Guantes no estériles
- Catéter intravenoso (abbocath) según cantidad a perfundir y calidad de la vena.
- Jeringa con suero fisiológico
- Tapón antirreflujo (variable)
- Equipo de perfusión
- Apósito preferiblemente transparente



PROCEDIMIENTO

En primer lugar debemos informar al paciente del procedimiento a realizar para pedirle su colaboración así como colocar al paciente en decúbito supino con los brazos extendidos sobre el cuerpo.

- Ponerse los guantes y purgar el equipo de perfusión conectado al suero.
- Seleccionar la vena a puncionar. Se recomienda valorar inicialmente las venas más distales (dorso de la mano o antebrazo) pero en el Servicio de Urgencias empezaremos valorando aquellas que tengan mayor calibre (flexura cubital o en brazo) con la intención de que los fluidos y la medicación lleguen más rápido al corazón.
- Colocar el compresor 10 – 20 cm proximal al punto elegido de tal manera que pueda aflojarse con facilidad y con una sola mano.
- Desinfectar la zona a puncionar con el antiséptico tópico y dejar actuar (20 – 30 segundos para la clorhexidina).

- Si no se localizasen bien las venas, se puede pedir al paciente que abra y cierre el puño varias veces o dar ligeros golpes sobre los trayectos de las mismas para favorecer su distensión.
- Estirar la piel distal al punto de inserción con el pulgar de la mano no dominante para evitar la movilización del trayecto venoso durante la punción.
- Puncionar la vena formando un ángulo de 30-35° entre el abbocath y la piel, de forma firme y con el bisel hacia arriba.
- Una vez se observe sangre en la cámara del fiador, avanzar medio centímetro más y proceder a retirar parte del fiador para comprobar que la sangre refluye hacia el catéter. En caso afirmativo, avanzar el catéter de plástico hasta canalizarlo completamente sin haber retirado la totalidad del fiador.
- Aflojar el compresor con la mano dominante mientras se presiona con la mano no dominante la punta del catéter de tal forma que no refluya sangre. Una vez aflojado el compresor, extraer el fiador a la vez que se conecta el sistema de suero y comprobar la correcta colocación del catéter.
- Fijar el catéter con el apósito transparente dejando visible el punto de punción para vigilar la posible aparición de flebitis y anotar hora y día de punción.

CONSEJOS

- La elección del calibre del abbocath varía según calidad de las venas y el uso que vaya a darse:
- 16G: Traumatismos importantes y pacientes que vayan a ser sometidos a intervención quirúrgica mayor.
- 18G: Pacientes con fines quirúrgicos y para administrar hemoderivados.
- 20G: Pacientes no quirúrgicos y para administrar sueroterapia y medicamentos.
- 22 – 24 – 26G: Adecuado para lactantes, niños y adultos con venas extremadamente finas.
- Si además de canalizar una vía, tenemos que extraer sangre para su posterior análisis, aprovecharemos la canalización de la vena para ello, evitando un pinchazo más al paciente.
- Si al introducir el catéter por la vena vemos que muestra obstrucción parcial, podemos retirar parcialmente el catéter e introducir a través de él suero fisiológico mientras avanzamos el catéter hasta su total introducción.
- Evitar puncionar miembros inferiores, para evitar la aparición de tromboflebitis, especialmente en personas que tengan varices.
- Una vez que tenemos la vía canalizada y salinizada, si muestra obstrucción a la hora de administrar medicación intravenosa, realizaremos lavados con suero fisiológico, introduciendo entre 2 – 5 cc de suero lentamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Murillo, L., Montero, FJ., (2014). Medicina de urgencias y emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación, España: Elsevier.
- Vázquez, MJ., Casal, JR., (2017). Guía de actuación en urgencias, España: Panamericana.
- Julián, A., (2014). Manual de protocolos y actuación en Urgencias, España: Sanofi.
- Moya Mir, M., (2011). Normas de actuación en urgencias, España: Panamericana.